

KC桌面——外资精译

GS：HK与TMT与NSCLCKelunBiotech6990.

OptiTROP-Lung06 宣布 PFS 优效性：7月15日，科伦博泰宣布中国 III 期 OptiTROP-Lung06 试验（1L nsq-NSCLC，PD-L1 TPS<1%）获得阳性顶线结果，达到主要终点（PFS）。在与标准治疗方案（帕博利珠单抗联合培美曲塞/铂类）的头对头比较中，sac-TMT/帕博利珠单抗联合疗法显示出显著延长的 PFS 和积极的 OS 趋势，且安全性可控，未发现新的安全性信号。OptiTROP-Lung06 的阳性顶线结果标志着继 OptiTROP-Lung05（在 ASCO2026 上公布的 1L NSCLC PD-L1 TPS≥1% 人群中 PFS HR 为 0.35，见我们的要点，[链接](#)，[链接](#)）树立标杆之后，在 1L NSCLC 领域取得的又一次重要的中国 III 期成功，更重要的是，它提供了 sac-TMT/帕博利珠单抗联合疗法优于帕博利珠单抗/化疗联合疗法的直接证据（而 Lung05 试验使用帕博利珠单抗单药作为对照组）。

关注 ESMO 数据详情，重申 9-12 个月 PFS

预期：随着阳性顶线结果的公布，我们预计详细数据将在即将召开的大会上分享，注意到管理层曾考虑提交 ESMO LBA（见我们的公司日要点）。我们重申此前对 Lung06 试验 9-12 个月 PFS 的预期，依据是：1) 中国 II 期 OptiTROP-Lung01 试验显示，在 TPS<1% 亚组中，sac-TMT/A167 联合疗法的 PFS 为 12.4 个月；2) 来自 Lung05 试验的增量信息，我们估计 sac-TMT/帕博利珠单抗联合疗法在 PD-L1 TPS 1-49% 亚组中的 mPFS 为 13-15 个月，但需要注意的是，由于 PD-L1 表达水平较低，预计 TPS<1% 人群的生存获益更短。

针对 KEYNOTE-189 人群的全球临床计划的另一个关键去不确定性步骤

人群：我们认为 OptiTROP-Lung06 是 sac-TMT 覆盖 1L NSCLC 的关键一环（图表 1），同时市场持续讨论 MRK 是否会启动（以及如何启动）针对 KEYNOTE-189 人群（1L NSCLC 中帕博利珠单抗+化疗，无论 TPS 水平，约 40% TPS<1%）的全球 III 期试验，核心争论在于 sac-TMT/IO 联合疗法相对于帕博利珠单抗/化疗联合疗法在 1L NSCLC 中的优效性程度，以便在全球 III 期头对头试验中确保显著的生存优效性。我们认为 Lung05/06 试验的阳性结果是该讨论中逐步去不确定性的步骤，具体包括：1) 来自 Lung05 数据的间接启示，特别是 sac-TMT/帕博利珠单抗联合疗法在 PD-L1 TPS 1-49% 亚组中观察到的强劲 PFS（相对于帕博利珠单抗单药的 HR 为 0.28），提示 mPFS 为 13-15 个月，与帕博利珠单抗/化疗双药联合疗法历史数据（mPFS 范围 7-9 个月）相比，似乎有利于达到统计学显著性（见我们对 Lung05 亚组的详细要点）；2) 即将在 ESMO 上公布的 Lung06 详细数据将提供 sac-TMT/帕博利珠单抗联合疗法优于帕博利珠单抗/化疗联合疗法的直接头对头证据。回顾一下，科伦博泰管理层曾分享，针对 1-49% 人群的 sac-TMT 全球 III 期试验，问题在于使用 PD-1 还是 PD-1/VEGF 作为联合搭档，我们预计随着 Lung06 详细数据的公布，针对 KEYNOTE-189 人群的潜在全球 III 期试验将有更多讨论。

图表 1：我们预计 OptiTROP-Lung05/06 数据是 1L NSCLC 全球 III 期试验的关键去不确定性步骤，重点关注 PD-L1 1-49% 组当前标准治疗方案及 sac-TMT 在 1L NSCLC 中的 III 期试验布局

	PD-L1 TPS ≥ 50% (20-35%)	PD-L1 TPS 1-49% (25-40%)	PD-L1 TPS < 1% (20-30%)
Squamous (25-30%)	Pembrolizumab (monotherapy)	Carboplatin* + paclitaxel* + pembrolizumab	Carboplatin* + paclitaxel* + pembrolizumab
Non-squamous (up to 70%)	Pembrolizumab (monotherapy)	Carboplatin* + pemetrexed + pembrolizumab	Carboplatin* + pemetrexed + pembrolizumab

* Only used in induction phase for up to four cycles (12 weeks)

TroFuse-023
TroFuse-007

OptiTROP-Lung05
OptiTROP-Lung06

图表 1

来源：NCCN 指南

，基于不确定性调整后的 DCF 方法。我们将 2027E/2028E 每股收益从 7.49 元人民币/14.32 元人民币调整为 7.51 元人民币/14.46 元人民币，以反映对 1L NSCLC 的更强信心，具体包括：1) Lung06 的成功概率从 81% 提高至 90%；2) 中国以外地区 1L NSCLC PD-L1 TPS <50% 的成功概率从 54% 提高至 63%。

科伦博泰是一家临床阶段的生物科技公司，专注于为全球患者开发和商业化差异化的抗体药物偶联物。我们认为科伦博泰具备成长为有影响力的全球 ADC 参与者的良好条件，原因在于：1) 差异化的后期 ADC；2) 深厚的研发专业知识推动管线扩张；3) 与 MSD 在全球市场准入方面的广泛合作（3 个临床阶段和 4 个临床前资产，MSD 为顶级股东）以及与科伦药业（母公司）在中国的商业化合作。我们预计 SKB264 (TROP2 ADC) 将成为科伦博泰未来增长的关键驱动力，原因在于：1) TROP2 过表达的适应症范围广泛（如乳腺癌/非小细胞肺癌/尿路上皮癌/胃癌）；2) SKB264 独特的药物设计可能如早期令人鼓舞的数据所示，相较于同类 TROP2 ADC 带来临床获益；3) 充分利用 MSD 在全球市场的专业知识和网络推动临床开发和商业化。我们更新公司观点。主要不确定性：1) 开发新适应症和未来 ADC 的研发不确定性；2) ADC 领域竞争日益激烈；3) 有限的商业化生产和销售记录；4) 人才竞争挑战；5) 合作中的联盟不确定性。

我们对科伦博泰更新公司观点。，假设：1) 折现率 11%；2) 终值增长率 3%；3) 基于不同阶段行业平均成功率并根据现有临床数据调整的成功概率。主要不确定性：1) 开发新适应症和未来 ADC 的研发不确定性；2) ADC 领域竞争日益激烈；3) 有限的商业化生产和销售记录；4) 人才竞争挑战；5) 合作中的联盟不确定性。

来源：公司数据，GS估计，FactSet。价格截至 2026 年 7 月 14 日收盘。

增长基于公司的前瞻性销售增长、EBITDA增长和EPS增长（对于资金股，仅使用EPS和销售增长），百分位数越高表示公司增长越强。财务回报基于公司的前瞻性ROE、ROCE和CROCI（对于资金股，仅使用ROE），百分位数越高表示公司财务回报越高。估值倍数基于公司的前瞻性P/E、P/B、价格/股息（P/D）、EV/EBITDA、EV/FCF和EV/债务调整后现金流（DACF）（对于资金股，仅使用P/E、P/B和P/D），百分位数越高表示公司交易倍数越高。综合百分位数计算为增长百分位数、财务回报百分位数和（100% - 估值倍数百分位数）的平均值。财务回报和估值倍数使用GS分析师对未来至少三个季度后的财年年底的预测。增长使用对未来至少七个季度后的财年与至少三个季度后的财年进行比较的输入数据（所有指标均基于每股）。

有关我们如何计算GS因子概况的详细说明，请联系您的GS代表。

并购排名：公司情况更新

在我们的全球覆盖范围内，我们使用并购框架审视公司，综合考虑定性因素和定量因素（这些因素可能因行业和地区而异），以纳入某些公司可能被收购的潜力。然后我们分配并购排名，作为对我们覆盖范围内评级公司进行评分的方法，从1到3，其中1表示公司成为收购目标的高概率（30%-50%），2表示中等概率（15%-30%），3表示低概率（0%-15%）。对于排名为1或2的公司，根据我们部门的标准指引。并购排名为3被视为不重要，并且可能在研究报告中讨论或不讨论。

Quantum

Quantum是GS的专有数据库，提供详细的财务报表历史、预测和比率访问。它可用于对单一公司进行深入分析，或在不同行业和市场公司之间进行比较。